

肺血栓塞栓症予防対策 外来、病棟における開始の手順

肺血栓塞栓症とは、下肢及び骨盤など深部静脈に生じた血栓が肺動脈を閉塞し、急性の肺循環障害を生じさせる病態を指す。特異的な早期症状がなく突然発症し死に至る経過をたどる確率の高い疾患の一つである。ことに周手術期は、血栓形成の危険因子とされるウィルヒョウ三徴、うっ血、血管内皮損傷、凝固亢進の条件が複数重なっていることから、肺血栓塞栓症の発生リスクが最も高い。その為、積極的な予防対策をとる必要がある。予防策は歩行が可能となるまで実施する。

外 来	女性ホルモン剤、類似薬等の服用の有無を確認。服用している患者には休薬を説明する。	肺血栓塞栓症予防のためパンフレット 女性ホルモン剤、類似薬(エビスタ、ビビアント等)の服用中止の説明書
	以下の①②③④が当てはまる患者に関しては、DVT及びPTE予防として足関節の底背屈運動を指導する。 ① 手術が決まっている。 ② 何らかの理由で、自宅あるいは施設(病院)で入院を待機する。 ③ 臥床安静を要する(歩けない)。 ④ 今回の受傷(発病)前は、歩行が可能であった(介助で移動動作が可能な場合も含む)。	
病 棟	入院時、患者、家族に肺血栓塞栓症予防策について説明する。このとき、 <u>足関節底背屈運動</u> についても説明し指導を行い、家族に対しても面会時など、運動の実施の協力を得る。 ①足関節底背屈運動の方法の説明と指導。 10回1セットを1日3回(午前、午後、寝る前)、できる人は3回以上 ②自力でできない場合は、他動的に実施する。	肺血栓塞栓症予防のためパンフレット 女性ホルモン剤、類似薬(エビスタ、ビビアント等)の服用中止の説明書
	「肺血栓塞栓症予防のためのリスク判定」のテンプレートを確認し指示受けをする。予防が必要な患者で指示が出ていない場合は、医師に指示を依頼し、指示受けを行う。	「肺血栓塞栓症予防のためのリスク判定」テンプレート
	判定が、中リスク以上は、指示に従って看護指示をあげ、観察項目(下肢腫脹・下肢疼痛・浮腫(片側のみ)・皮膚色(紫または赤)・呼吸困難・胸痛・SPO2値・抗凝固療法を実施している場合は創部出血)を経過表に入力し、看護計画を立案する。 歩行が可能となり、指示中止が出るまで行う。	
	弾性ストッキングについて ①足周囲をメジャーで測定し、サイズを決定する。 ★ 適合するサイズがない場合は医師に相談する。 ②履かせる部分に、保湿クリームを塗り、ストッキングを履かせる。 家族に保湿クリームの購入をお願いする(ニベアなどでも可能)。 家族が持ってくるまでの間は、病棟用を使用する。 ③弾性ストッキング装着を電子カルテに入力。 (肺血栓塞栓予防管理量として請求が行われる。) ④1日1回(10時)にストッキングを脱がせて皮膚ケアを実施する。 ストッキングが汚れている場合は、家族に洗濯を依頼する。 洗い替えのストッキングは売店に販売していることを説明する。 替えがない場合は病棟用を貸し出す(無料)。 ★ 何らかの理由で、ストッキングの装着継続が困難な場合は、医師に相談する。	弾性ストッキング履き方シート 専用メジャー 弾性ストッキング 保湿クリーム 観察ポイントカード